

皮膚科における感染症診療の最前線

名古屋市立大学大学院
加齢・環境皮膚科学
加藤裕史

slido

Join at
slido.com
#3120 611



例題

4歳、女児。発疹を主訴として来院した。前胸部と腹壁とに発赤と水疱とを伴う発疹を認める。発疹の数は増加し、分布も拡大してきている。通園している幼稚園で同様の発疹を認める児が数人いるという。上腹部の写真を次に示す。適切な処置はどれか。



- A アルコール消毒
- B 抗菌薬服用
- C 抗ウイルス薬服用
- D 抗ヒスタミン薬服用
- E 副腎皮質ステロイド薬軟膏塗布

伝染性膿痂疹(とびひ)

水疱性膿痂疹: **黄色ブドウ球菌**感染が原因となる
→ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群(SSSS)に発展することがある

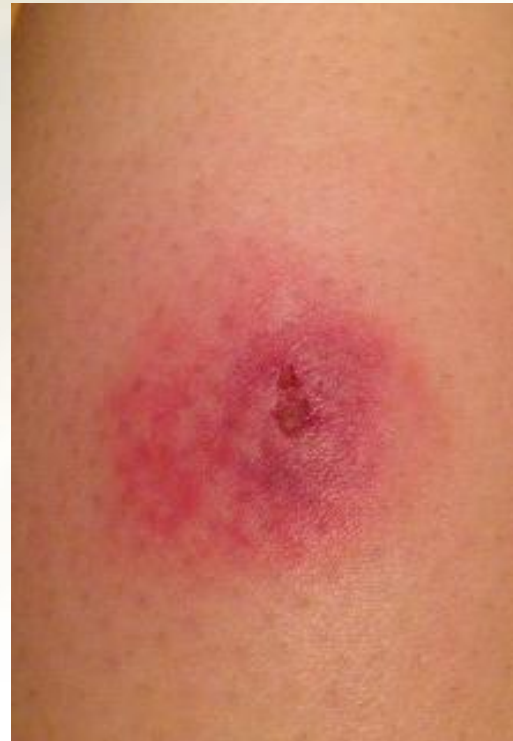
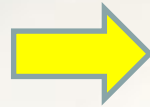
痂皮性(膿疱性)膿痂疹: **A群β溶連菌感染**が原因となる



伝染性膿痂疹(とびひ)



虫刺され、湿疹など



局所で細菌感染が発生



それを触った手で他の
部位をかきむしると周囲
に拡大

CA-MRSA(市中型MRSA)

近年、MRSAは2種類に分類される。

Hospital-acquired MRSA; HA-MRSA

Community-acquired MRSA; CA-MRSA

- ・βラクタムのみ耐性を持つ株が多い
- ・皮膚感染症を来す事が多い
- ・Panton-Valentine ロイコシジン(PVL)と呼ばれる白血球破壊毒素を産生することがある。
- ・壊死性筋膜炎、重症膿痂疹などの報告が多い。



例題

31 65歳の女性。発熱を主訴に来院した。2日前から悪寒を伴う39℃台の発熱と右顔面の痛みが出現したため受診した。鼻閉や鼻汁はない。生来健康で、アレルギー歴や外傷歴はない。意識は清明。体温38.4℃。脈拍92/分、整。血圧134/68 mmHg。呼吸数20/分。顔面に右を主体とする腫脹があり、左右差を認める。右額面から、右頬部にかけて硬結と圧痛を伴う浮腫性紅斑を認める。右眼に充血はなく、眼球運動は正常である。顔面の写真(別冊No. 2)を別に示す。

考えられる病原微生物はどれか。

- a 結核菌
- b 緑膿菌
- c カンジダ
- d A群β溶連菌
- e 水痘・带状疱疹ウイルス



丹毒

主にA群 β 溶連菌感染が原因となる。
境界明瞭な圧痛を伴う紅斑がみられ、発熱、重篤感を伴う。
治療には主にペニシリン系薬剤を使用する。



例題

3ヶ月の乳児。昨日から左肩に紅斑が出現し、本日全身に拡大傾向を認めたため来院した。顔面と体幹との写真を次に示す。正しいのはどれか、2つ選べ。



- A 溶連菌感染症である
- B 粘膜症状はまれである
- C 急性糸球体腎炎を続発する
- D Nikolsky現象が陽性となる
- E 副腎皮質ステロイド薬が有効

ぶどう球菌性熱傷様皮膚症候群

黄色ブドウ球菌から、表皮剥脱性毒素により皮膚剥脱が起こる

Nikolsky現象が陽性であり、抗生剤の全身投与が必要



Nikolsky現象

正常に見える皮膚も、摩擦刺激により
容易に剝脱してびらんが生じる現象



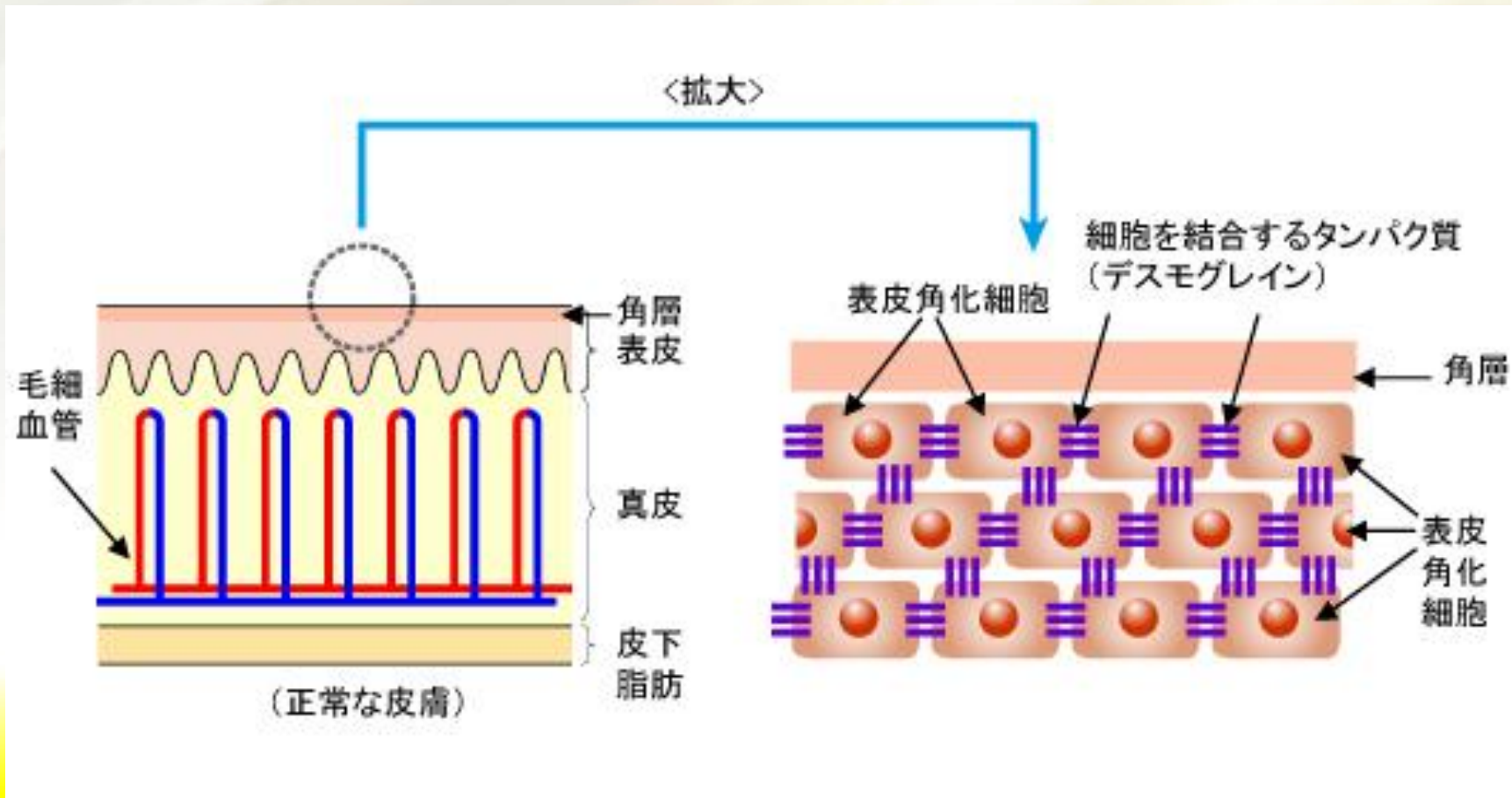
Nikolsky現象

ニコルさん	→Nikolsky現象
てん	→天疱瘡
てん	→TEN(中毒性表皮壊死症)
と	
水疱できて	→表皮水疱症
SOS	→SSSS(ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群)



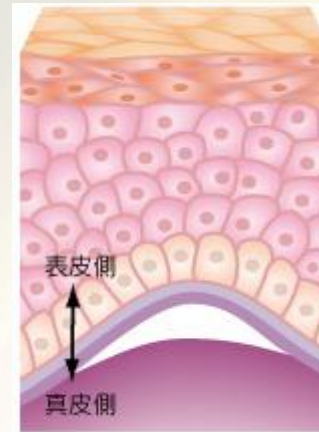
SOS !!

ぶどう球菌性熱傷様皮膚症候群 もう少し細かいお話

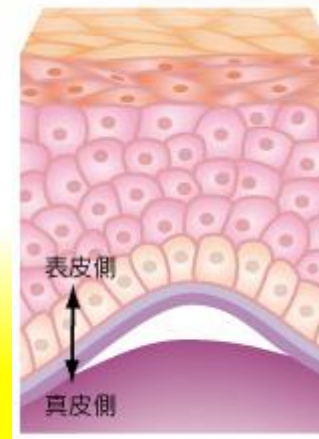
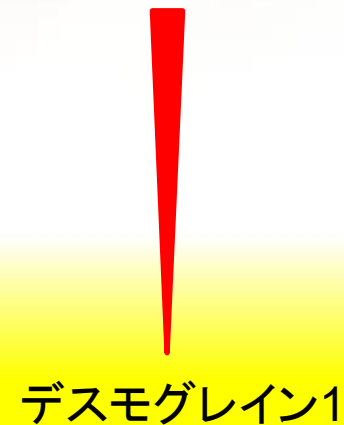


ぶどう球菌性熱傷様皮膚症候群 もう少し細かいお話

皮膚



粘膜



例題

20歳の女性。首の痛みを主訴に来院した。3日前から左側頸部に持続的な痛みを感じるようになった。体温36.8℃、脈拍76/分、整。左頸部に径1cmのリンパ節を2個触知し、いずれも表面平滑、弾性軟で可動性と圧痛とがある。甲状腺は触知しない。左後頸部の髪の毛の生え際に径1.5cmの発赤と腫脹とがみられ、毛包に分泌物が付着している。口腔内に異常はない。腋窩(わきのした)やそけい部にリンパ節を触知しない。心音と呼吸音とに異常を認めない。肝、脾を触知しない。頸部リンパ節腫脹の原因として最も考えられるのはどれか。



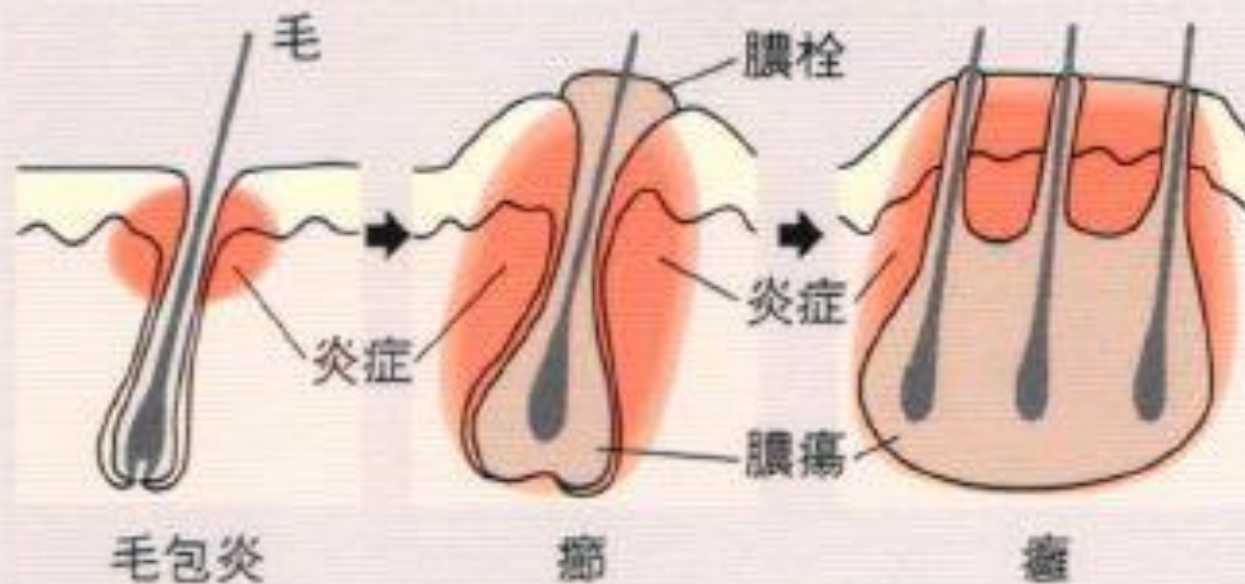


毛包の細菌感染症

毛包炎

せつ
(癰)

よう
(癰)



毛包の細菌感染症

毛包炎

せつ
(癰)

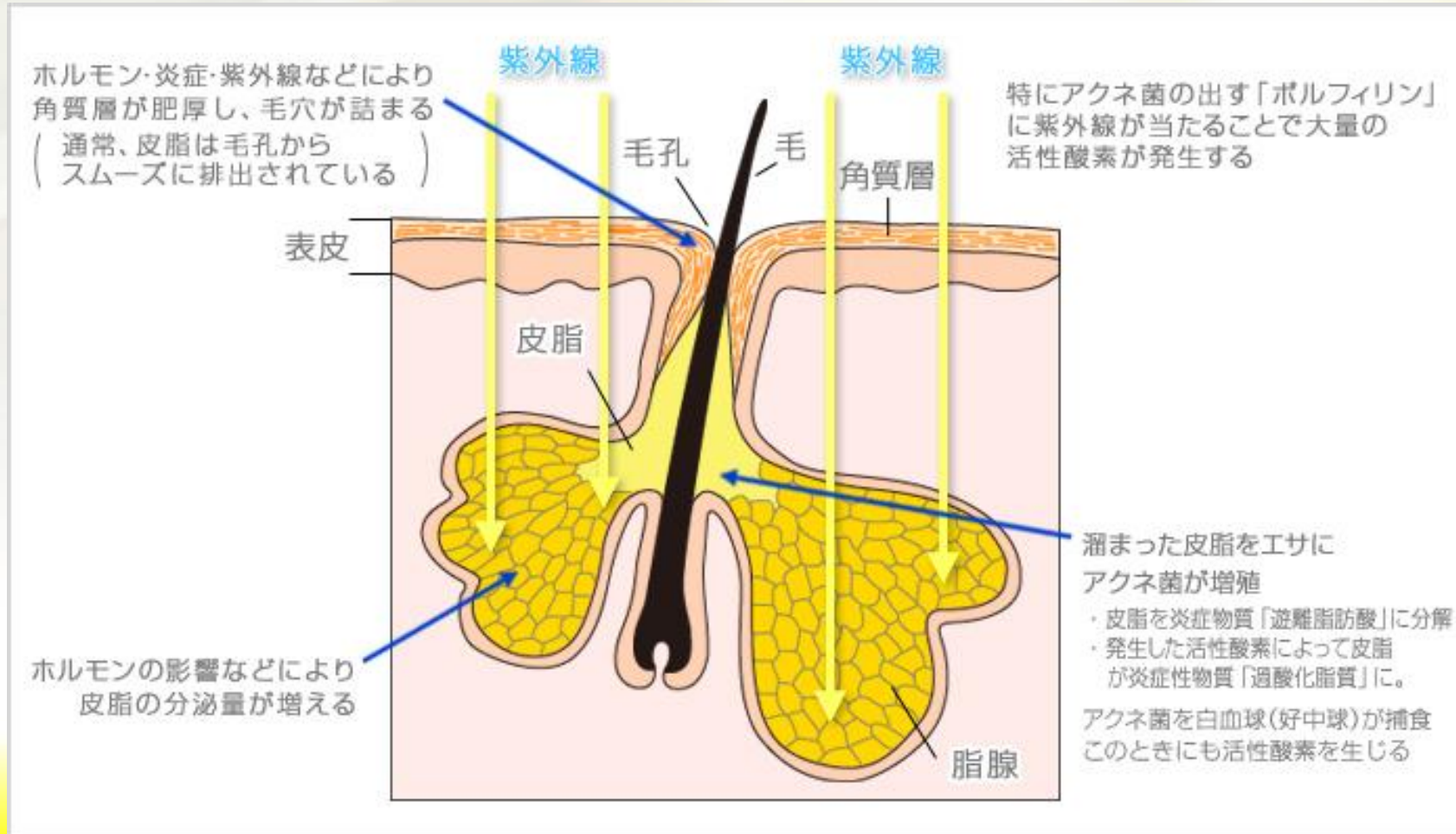
よう
(癰)

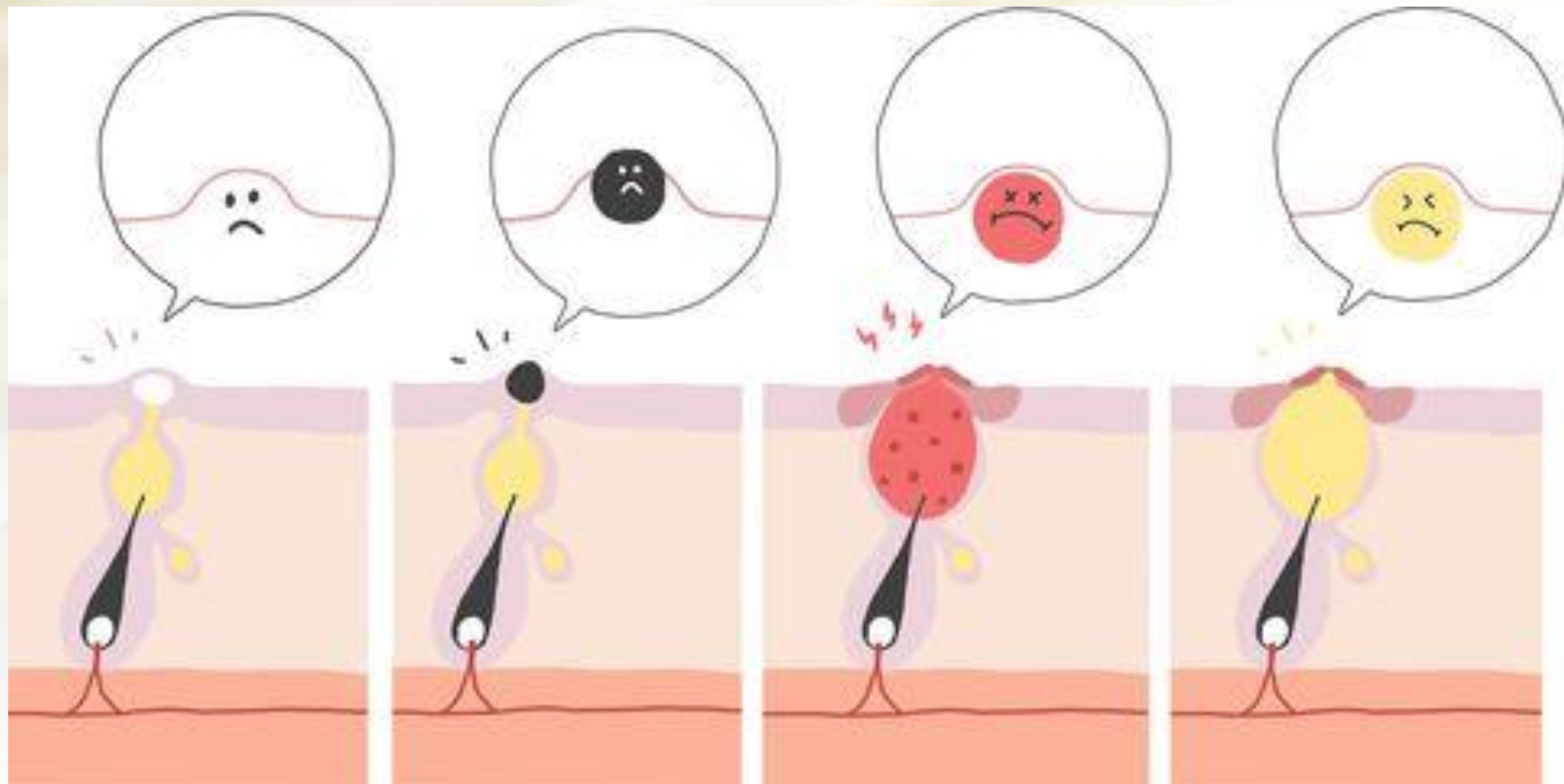


尋常性ざ瘡(ニキビ)



尋常性ざ瘡(ニキビ)





白ニキビ



黒ニキビ



赤ニキビ



黄ニキビ

ニキビの治療



白ニキビ

黒ニキビ

赤ニキビ

黄ニキビ

アダパレン

抗菌薬(外用、内服)

過酸化ベンゾイル

圧出

切開排膿

例題

23歳の男性。1ヶ月前から続く尾骨部成虫からの排膿を主訴に来院した。便通に異常はない。尾骨部正中が3cm大に腫脹している。中心部に瘻孔があり、排膿を認める。肛門周囲膿瘍と痔瘻とは認めない。この疾患について誤っているものはどれか。

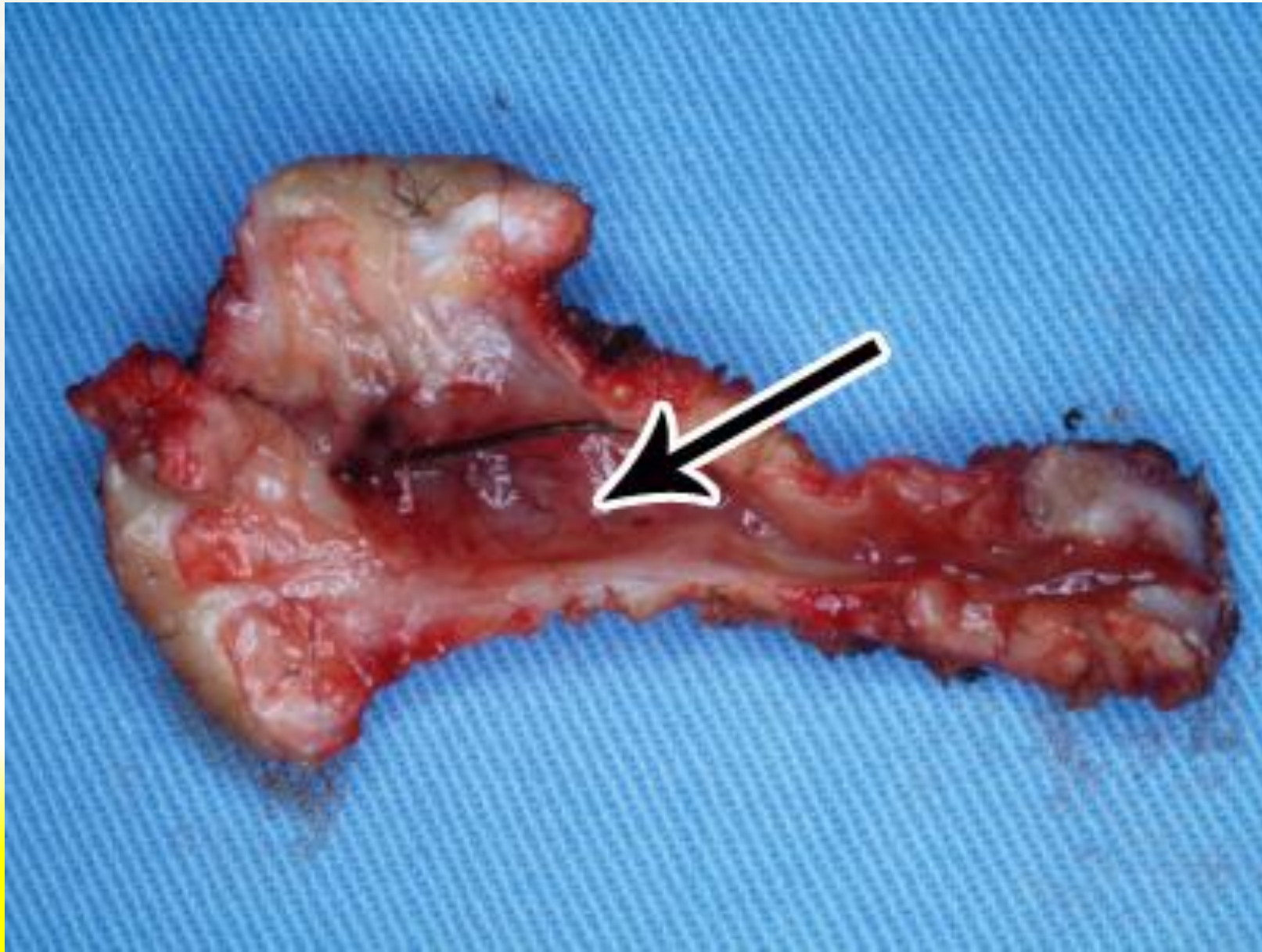
- A 多毛者に多い
- B 肥満者に多い
- C 白人に多い
- D 毛髪を含んでいることが多い
- E 抗菌薬投与で治癒する

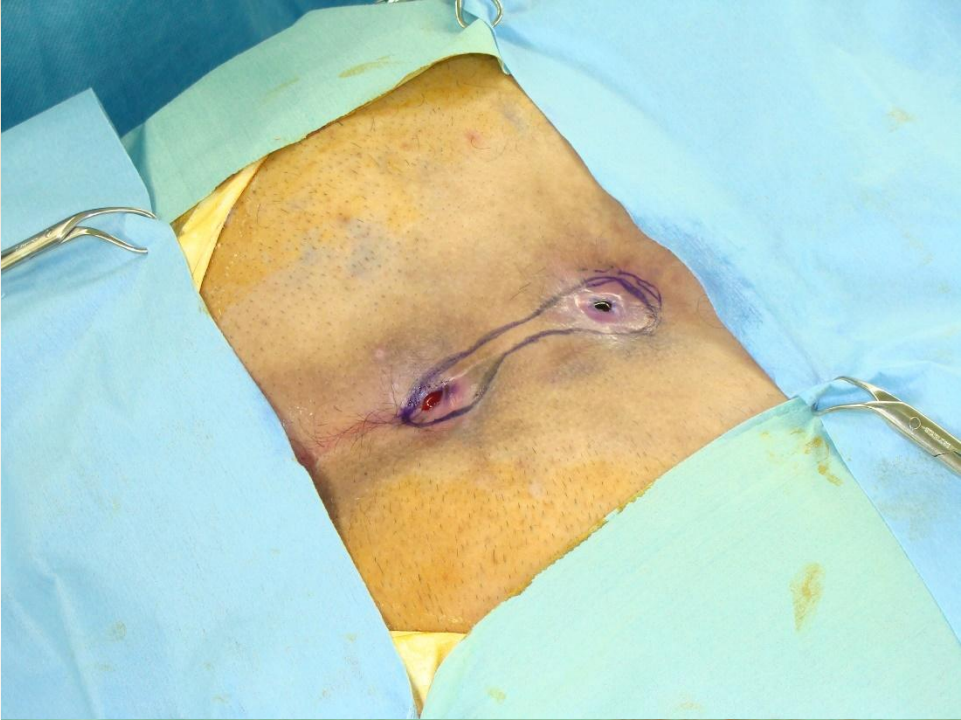


毛巢洞



毛巢洞



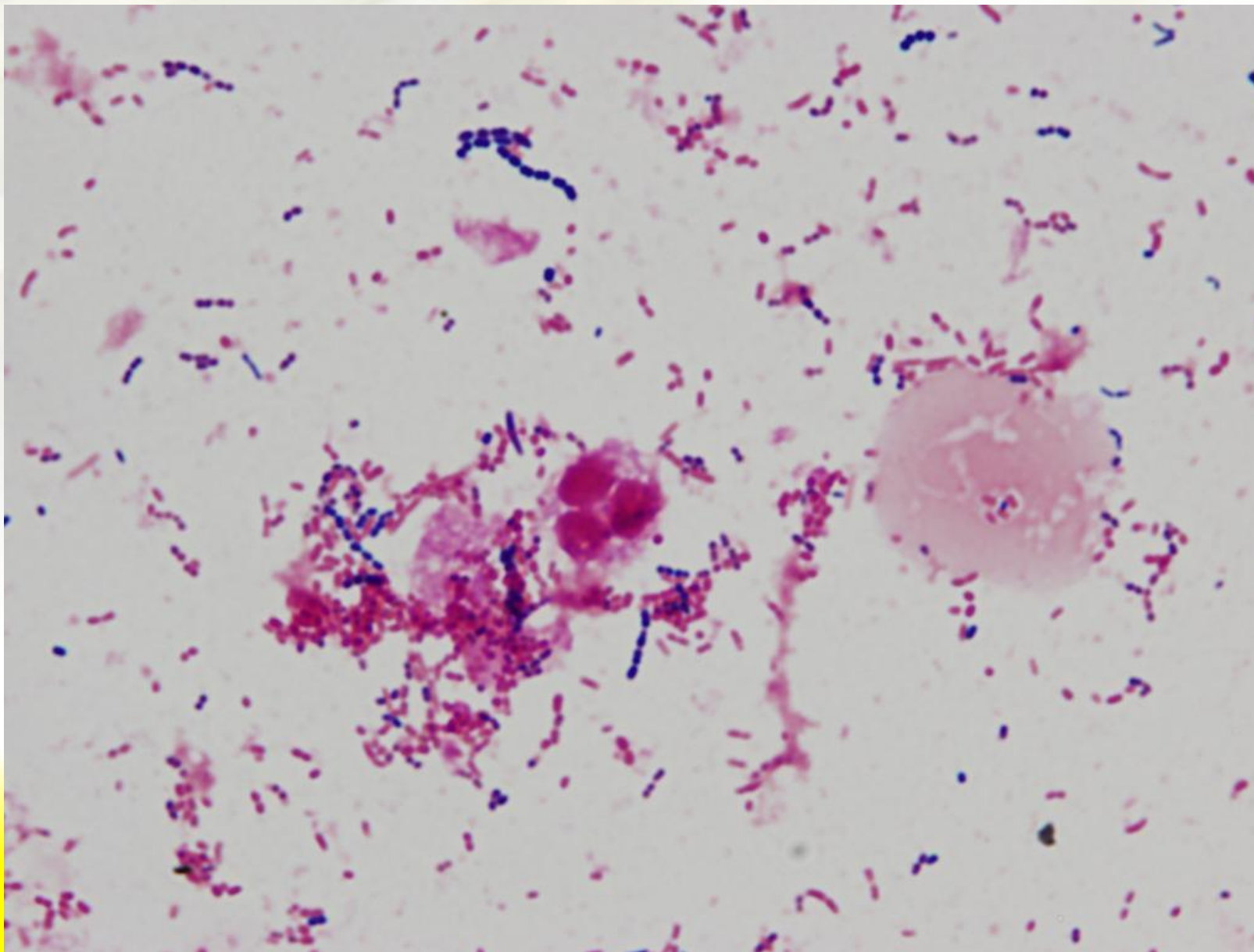


壊死性筋膜炎

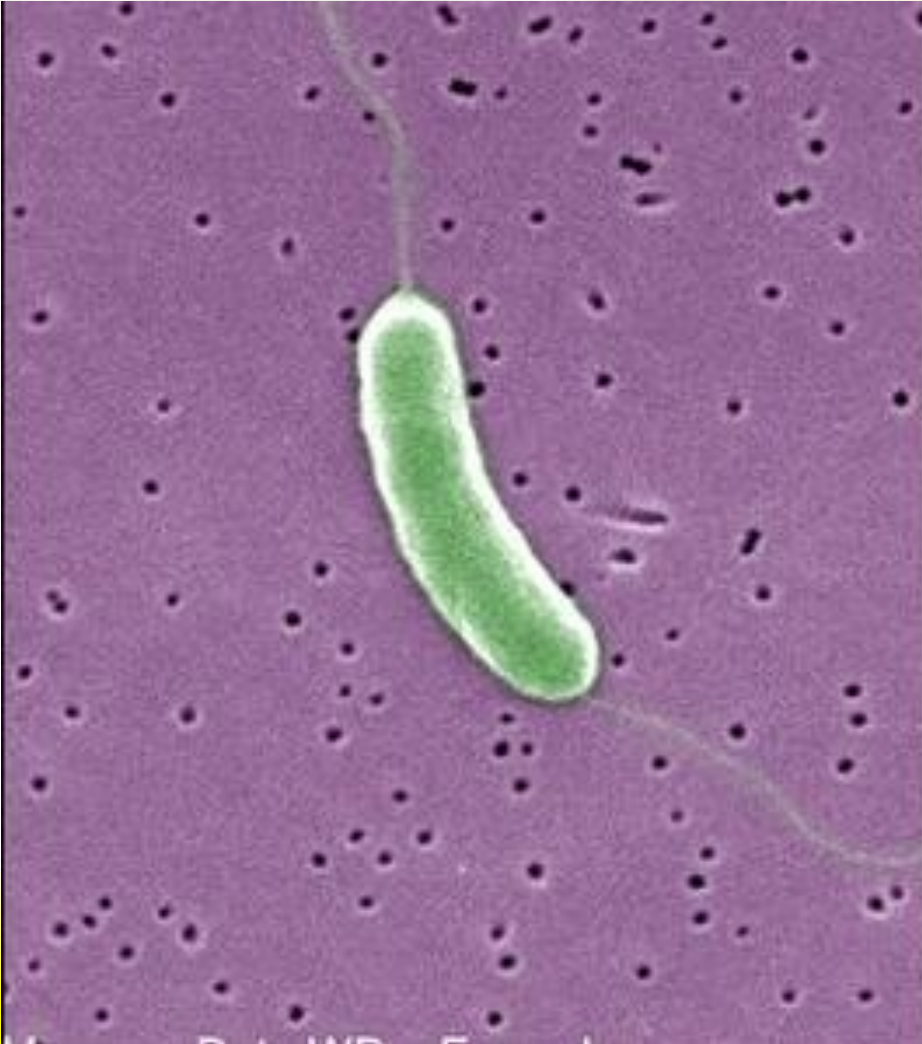


「人食いバクテリア」として話題に挙がることが多い「A群溶連菌」による皮膚軟部感染症（近年は他の細菌でも報告が増えている）
グラム染色でレンサ球菌が見られる。

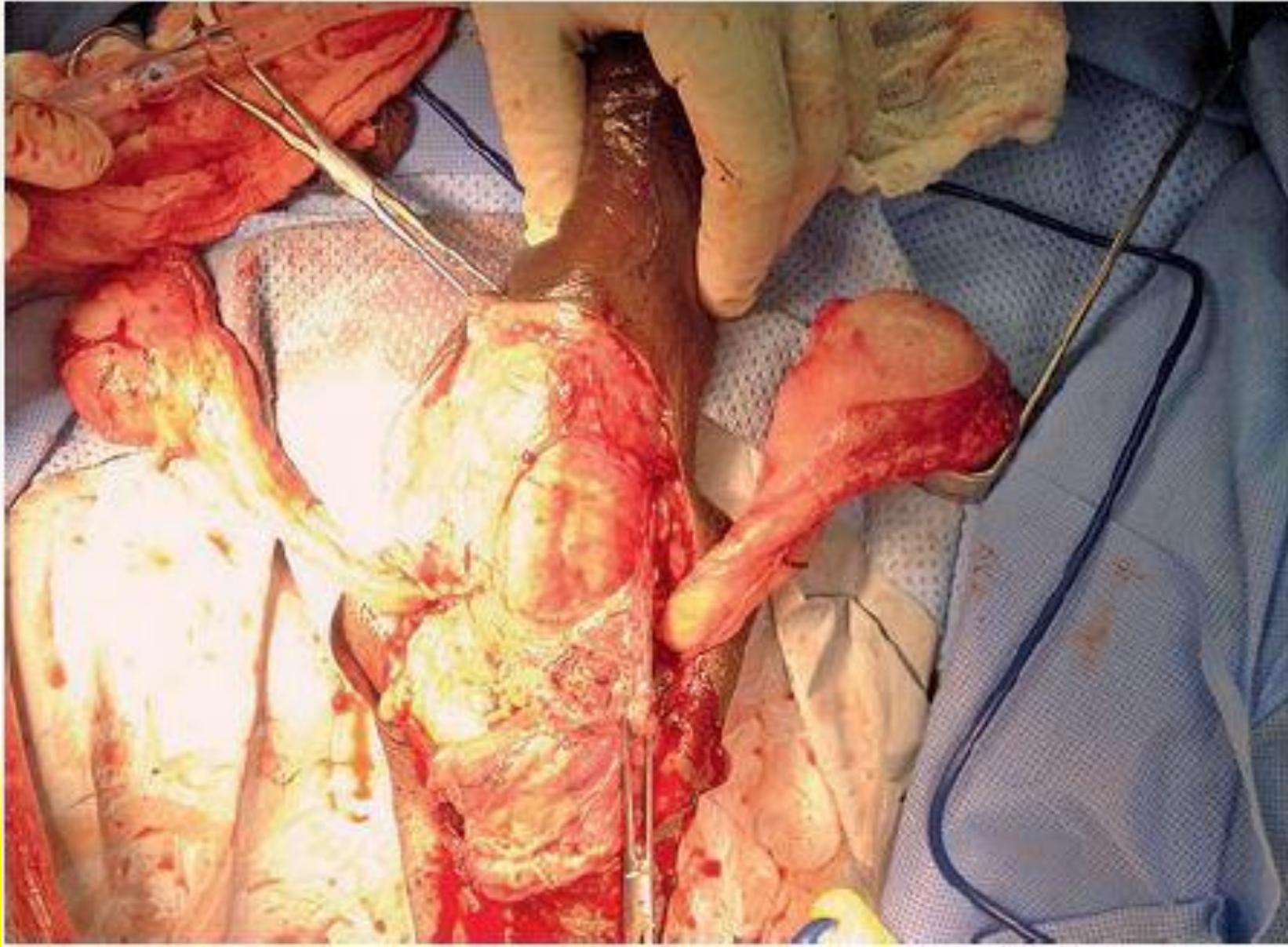
レンサ球菌



ビブリオ バルニフィカス



Fournier壞疽



ガス壊疽



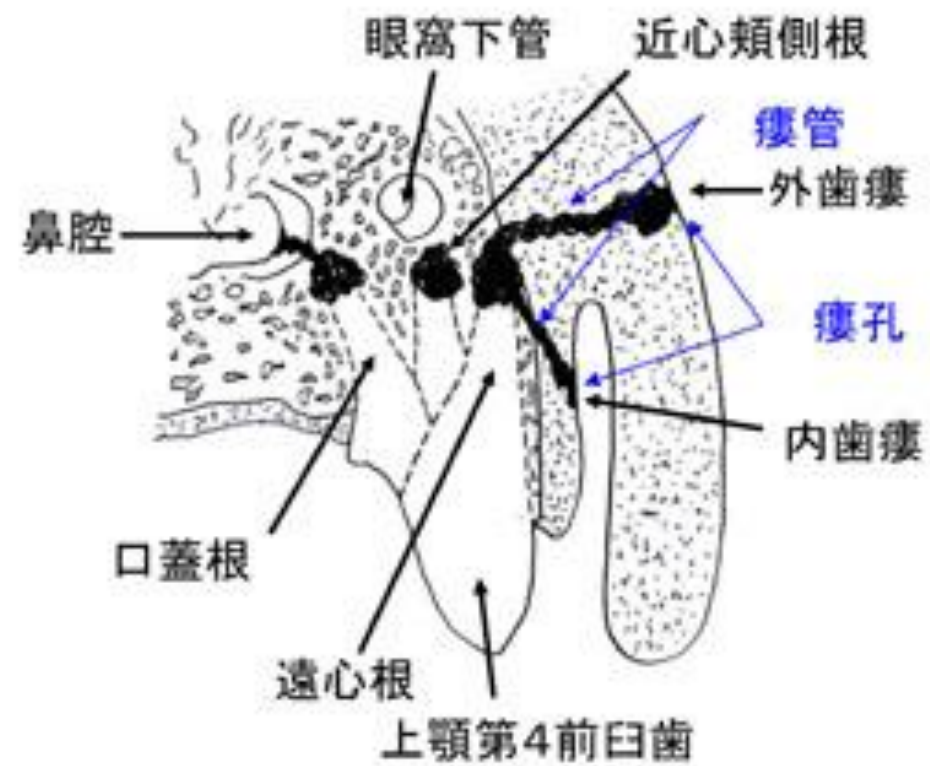
ガス壊疽

クロストリジウム性	非クロストリジウム性
潜伏期間は18時間～3日	潜伏期間は2週間以上
基礎疾患はない場合が多い	糖尿病、肝硬変などの基礎疾患
急激な発症	比較的緩徐な発症
しばしば筋肉内にガス像	脂肪層、筋膜周囲にガス像
筋酵素の上昇	筋酵素は上昇しないことが多い
グラム陽性桿菌	混合感染



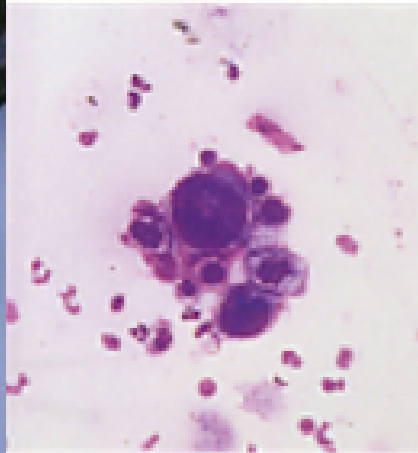
外齒瘻





例題

33歳の男性。発熱と顔面の皮疹とを主訴に来院した。幼少期からアレルギー性皮膚炎があり、治療を受けていた。2日前から38℃大の発熱、顔面の紅斑、びらんおよび小水疱が出現してきている。顔面の写真と水疱内容のTzank試験の結果を示す。原因として最も考えられるのはどれか。



- A EBウイルス
- B サイトメガロウイルス
- C 単純ヘルペスウイルス
- D 水痘・帯状疱疹ウイルス
- E ヒトパピローマウイルス

単純ヘルペス感染症



ヘルペスウィルス科

HHV-1（単純ヘルペスウィルス1型）→（主に）口唇ヘルペス

HHV-2（単純ヘルペスウィルス2型）→（主に）性器ヘルペス

HHV-3（水痘・帯状疱疹ウィルス）→水痘、帯状疱疹

HHV-4（EBウィルス）

HHV-5（サイトメガロウィルス）

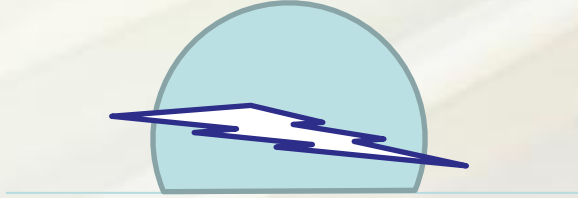
HHV-6 →突発性発疹

HHV-7 →突発性発疹

HHV-8 →Kaposi肉腫



Tzankテスト



水疱蓋を剪刀で
切除する。

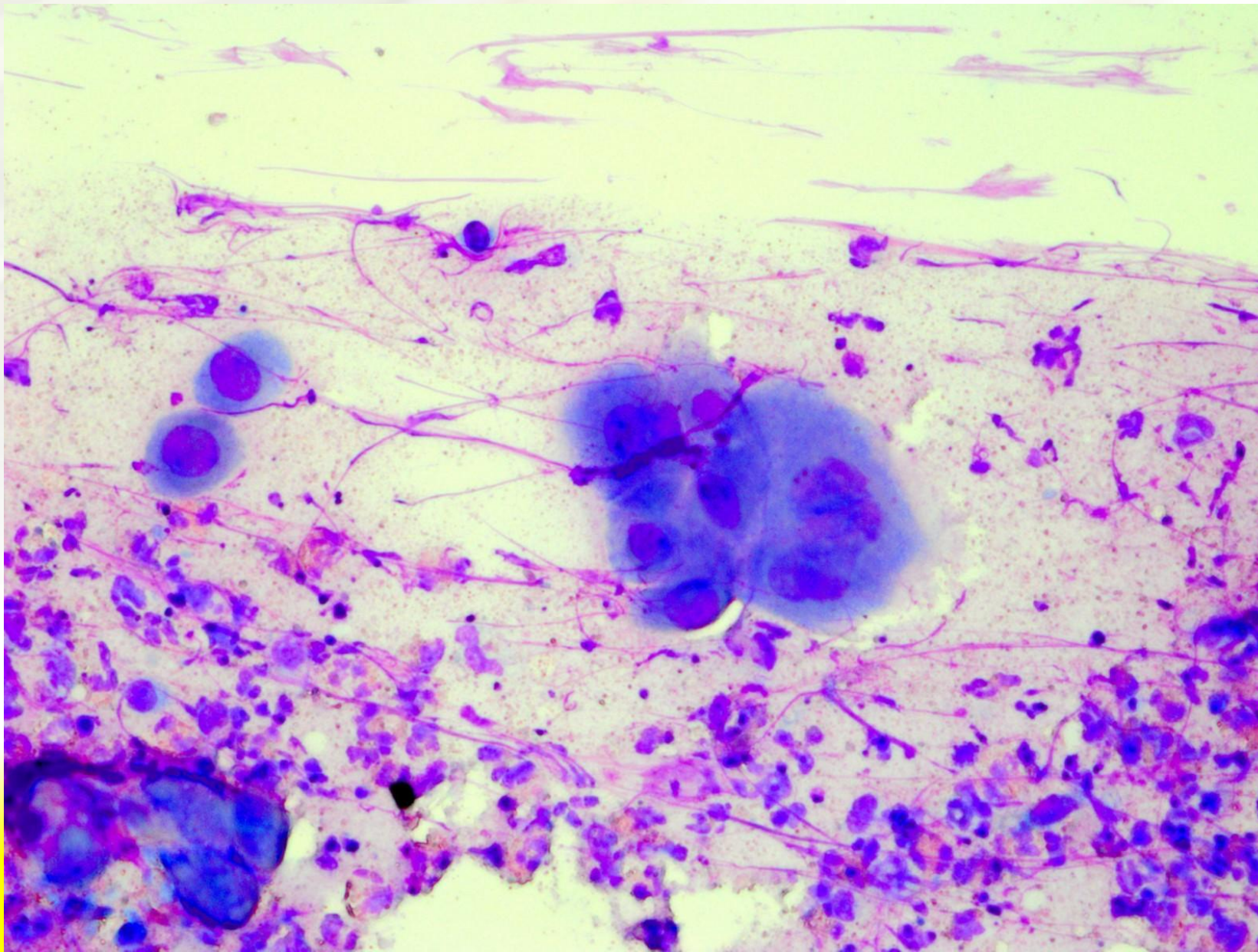


水疱蓋をスライ
ドガラスにこすり
つけ、風乾させ
る。

メイ・ギムザ染
色を行う。



Tzankテスト



例題

55歳の女性。背部の痛みを主訴に来院した。5日前から左背部に痛みを感じていた。痛みは皮膚表面がピリピリする感じであった。昨日より皮疹が出現したため受診した。

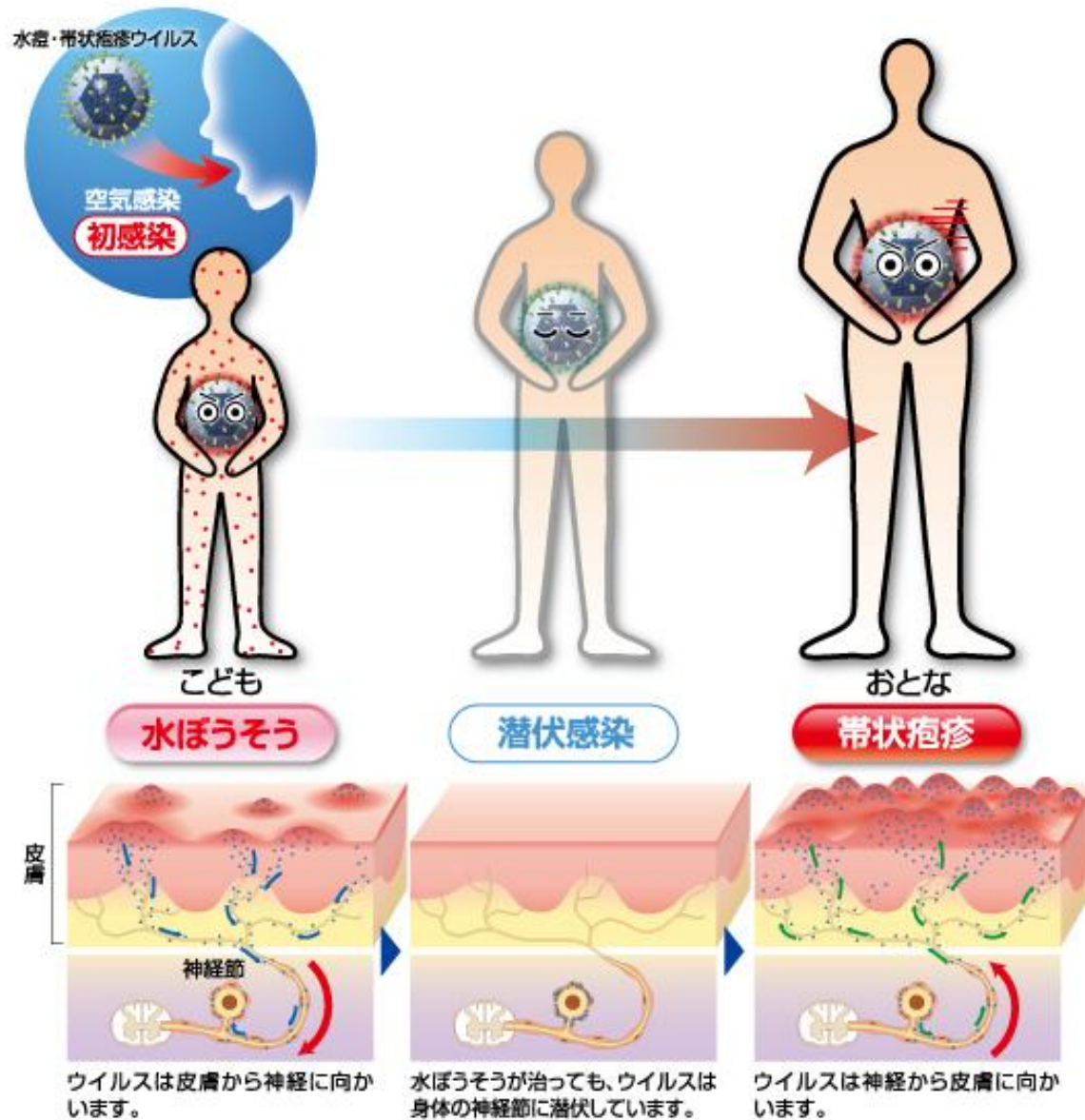
- 1) この病変を特徴付ける皮疹の種類はどれか
a, 紅斑 b, 水疱 c, 囊腫 d, びらん e, 膨疹
- 2) 診断と治療のために患者に確認すべきことはどれか
a, 喫煙歴 b, 水痘の既往 c, 東南アジアへの渡航歴
d, 野生動物との接触の有無 e, 長女の状況
- 3) 治療薬として適切なものはどれか
a, 抗菌薬 b, 解熱薬 c, 抗真菌薬 d, 抗ウィルス薬
e, 抗アレルギー薬



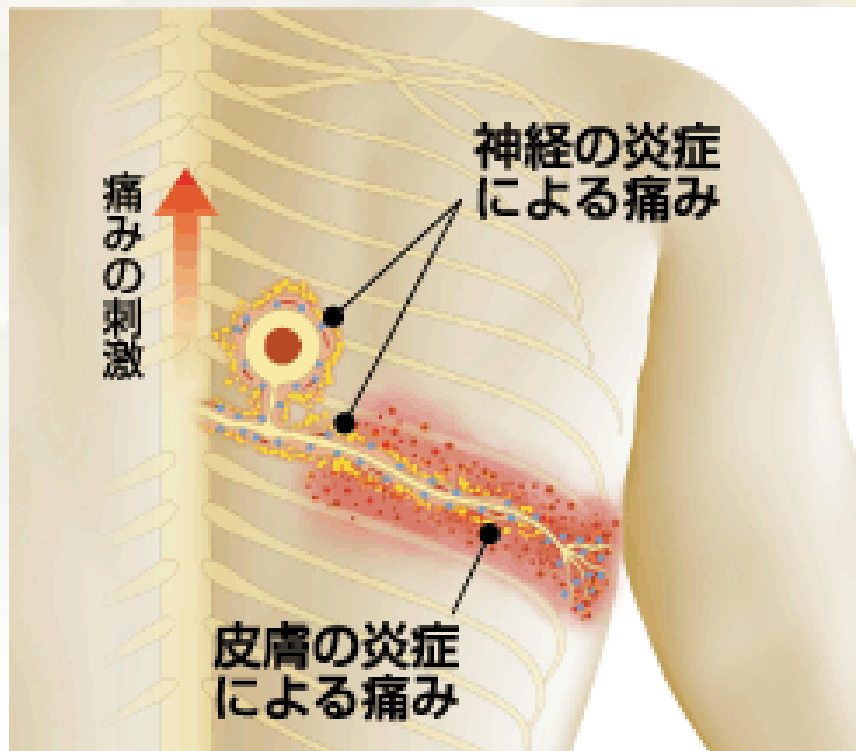
带状疱疹



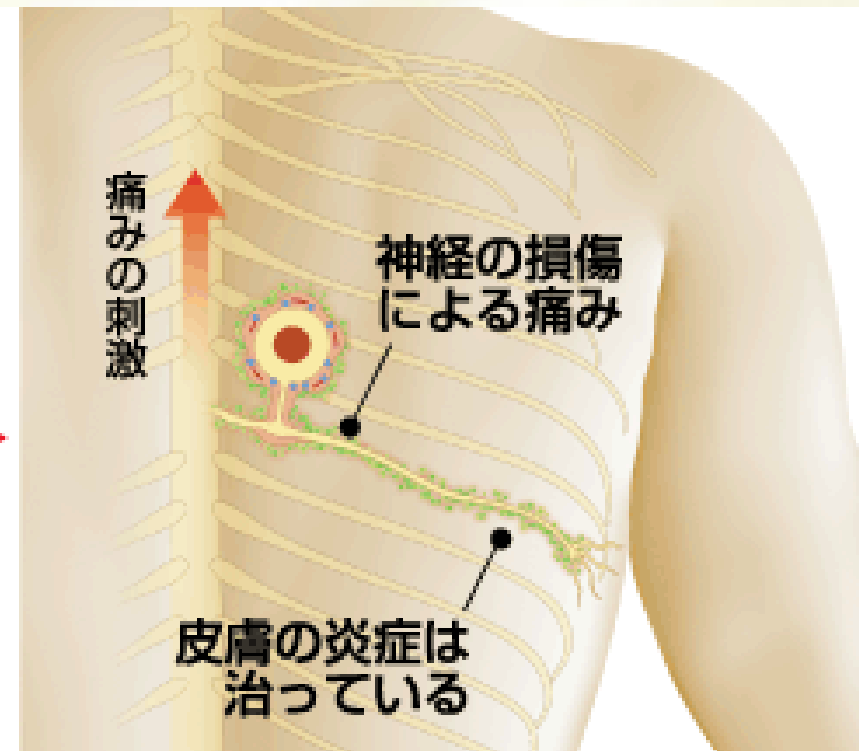
帯状疱疹



帯状疱疹後神経痛



急性期痛



帯状疱疹後神経痛

59 87歳の女性。自宅で倒れているところを知人が発見し救急車で搬入された。認知機能低下と脱水症の診断で入院加療を開始した。入院4日目に右臀部から膝窩にかけて水疱を伴う皮疹(別冊No. 23)が出現し、痛みを訴えている。意識レベルはJCSⅡ-10。身長158 cm、体重41 kg。血液所見：赤血球288万、Hb 7.1 g/dL、Ht 23 %、白血球7,760(桿状核好中球2 %、分葉核好中球84 %、好酸球1 %、好塩基球1 %、単球3 %、リンパ球9 %)、血小板16万。血液生化学所見：総蛋白4.5 g/dL、アルブミン2.2 g/dL、総コレステロール105 mg/dL。

皮疹に対して投与すべきものはどれか。

- a アシクロビル
- b イトラコナゾール
- c ST合剤
- d ペンジルペニシリン
- e メトロニダゾール

No. 23

(D 問題59)



臀部の皮疹の一部を拡大したもの



带状疱疹ワクチン



带状疱疹 ワクチンしましょう！

■フーズー皮膚科の狎鷗亭・千戸支店では、带状疱疹のワクチン接種を行っております。



50歳以上の成人は、带状疱疹の危険性を持っているため、
带状疱疹のワクチン接種をすることをお勧めいたします。

ワクチン接種群とプラセボ群での比較。

3年の追跡期間で計15,411例が対象

ワクチン接種群は 0.3人/1000人 プラセボ群は9人/1000人で带状疱疹を発症

汎発性带状疱疹



水痘



例題

5歳の男児。1年前から、酒杯に皮疹が出現した。放置したところ肘頭と膝蓋とにも拡大してきたので来院した。右手背の写真を示す。適切な治療はどれか。



- A 酸素療法
- B 凍結療法
- C 温熱療法
- D PUVA療法
- E 減感作療法

尋常性疣贅(いぼ)



ヒトパピローマウイルス
による皮膚感染症
液体窒素凝固療法で
治療

ボーエン様丘疹症



疣贅状表皮發育異常症



麻疹



風疹



手足口病



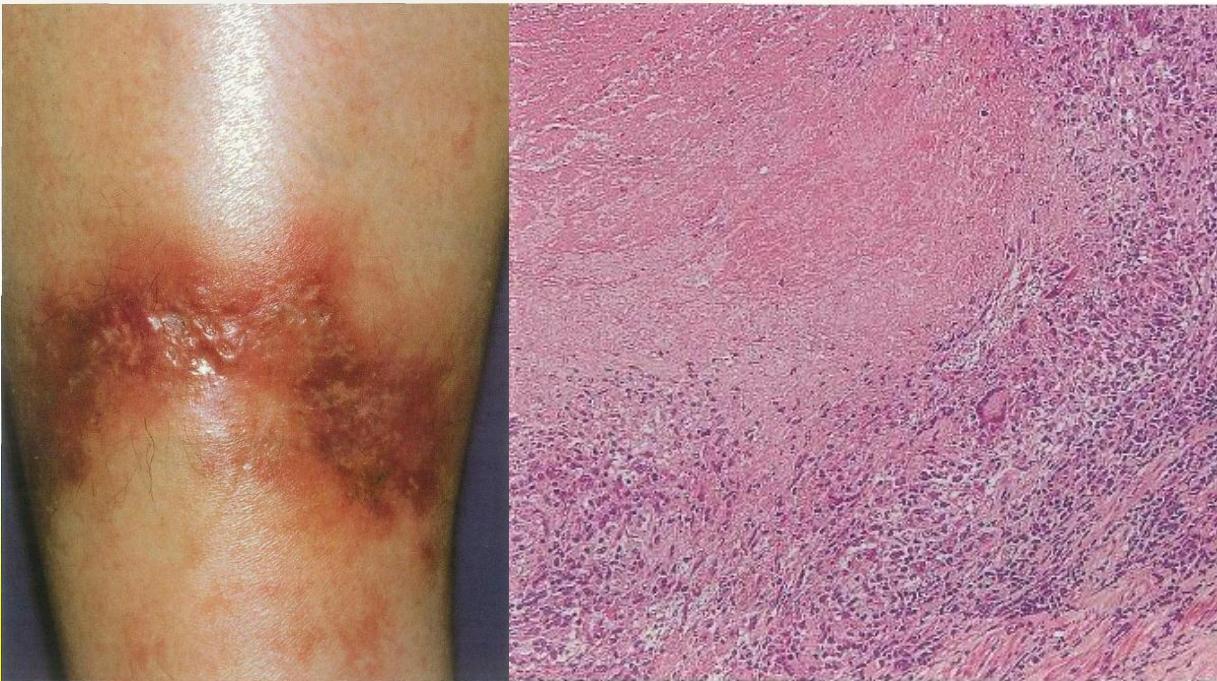
毎年6-8月頃に流行するウィルス性疾患で、通常はコクサッキーウィルスA16やエンテロウィルス71が原因であったが、ここ数年**コクサッキーウィルスA6**による手足口病が増加している。

通常発熱もなく、皮疹のみであったが、**コクサッキーウィルスA6**によるものは**高熱を呈することが多く、注意が必要**

また、**皮疹も手足に少なく、全身に出現することが多い。**

例題

54歳の女性、両側下腿の皮疹を主訴に来院した。皮疹は3ヶ月前から出現し、治癒していない。軽度の圧痛がある。下腿前面の写真と皮膚生検H-E染色とを次に示す。最も考えられるのはどれか。



- a. 結節性紅斑
- b. 硬結性紅斑
- c. 壊疽性膿皮症
- d. うっ滞性皮膚炎
- e. サルコイドーシス

皮膚抗酸菌感染症

・真性皮膚結核（結核菌の直接感染）

→ ヒトからヒトへ感染する

・結核疹（結核菌に対する皮膚の反応）

→ 皮疹で感染はしない

・非結核性抗酸菌感染症

→ ヒトからヒトへ感染はしない

・らい菌によるもの（ハンセン病）

→ ヒトからヒトへ感染する



皮膚抗酸菌感染症

- ・真性皮膚結核（結核菌の直接感染）
皮膚腺病、尋常性狼瘡、皮膚疣状結核
- ・結核疹（結核菌に対する皮膚の反応）
Bazin硬結性紅斑、丘疹壊疽性結核疹
、
腺病性苔癬、陰茎結核疹
- ・非結核性抗酸菌感染症
- ・らい菌によるもの（ハンセン病）



皮膚腺病



- ・肺やリンパ節からの皮膚への直接浸潤による皮疹
- ・頸部、下顎、胸部などに潰瘍を作る
- ・周囲には感染兆候を伴わないことが多く冷膿瘍と言われる
- ・元の結核病巣の治療が必要

尋常性狼瘡(Lupus vulgaris)

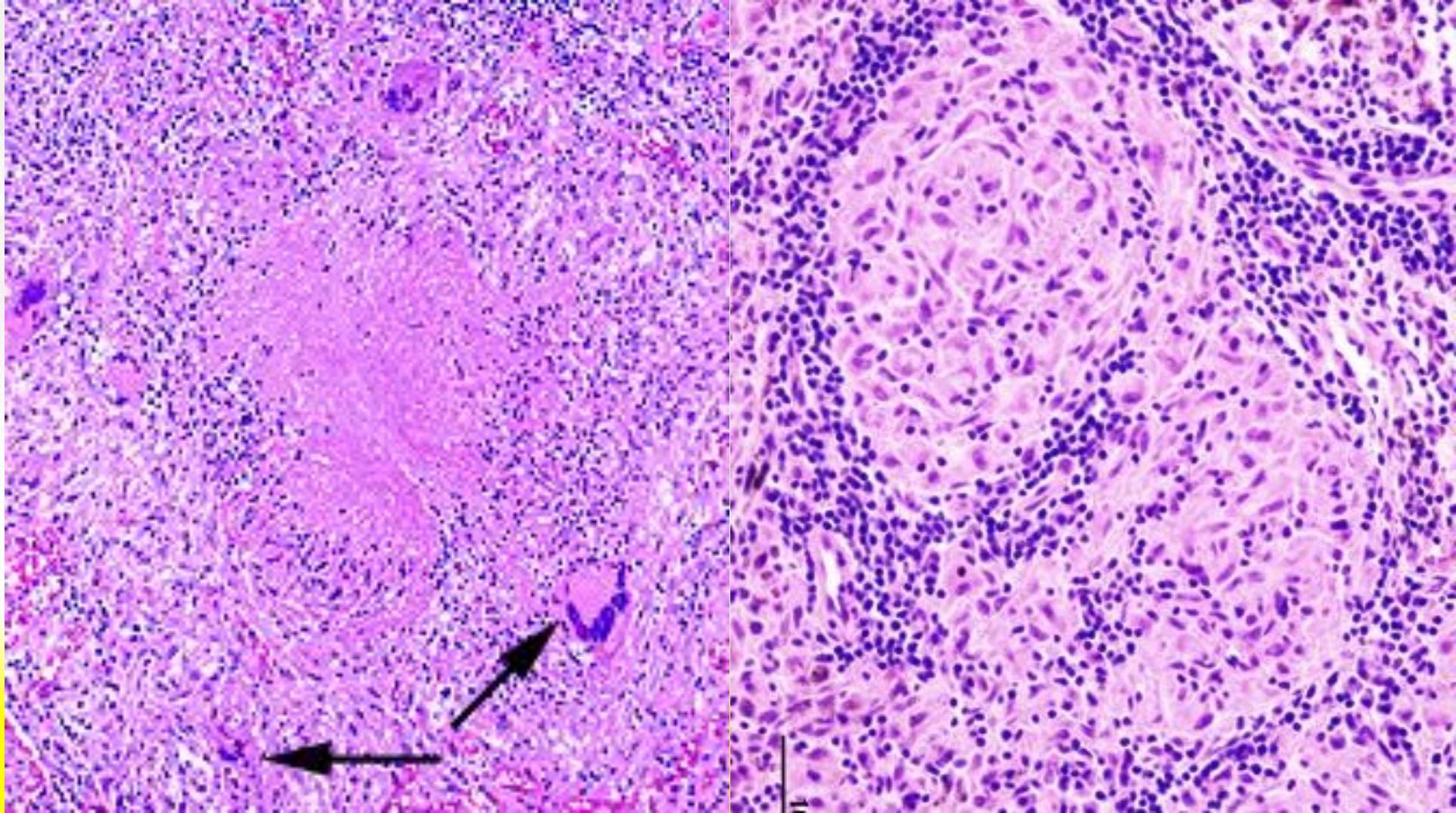


- ・肺やリンパ節などの結核病変から血行性やリンパ行性に皮膚に達した結核菌が増殖する
- ・元の結核病巣の治療が必要

狼瘡(Lupus)



非乾酪性肉芽腫との比較



Bazin硬結性紅斑



- ・結核菌に対する反応で起こる脂肪織炎、血管炎と言われている
- ・場合によって局所から結核菌が検出されることがある
- ・脂肪織炎、血管炎のみの病理像の場合と、乾酪性肉芽腫がみられる場合がある

真性皮膚結核の場合と、結核疹いずれの可能性もある

皮膚抗酸菌感染症

- ・真性皮膚結核（結核菌の直接感染）
皮膚腺病、尋常性狼瘡、皮膚疣状結核
- ・結核疹（結核菌に対する皮膚の反応）
Bazin硬結性紅斑、丘疹壊疽性結核疹、
腺病性苔癬、陰茎結核疹
- ・非結核性抗酸菌感染症
 - ・らい菌によるもの（ハンセン病）



例題

46歳の男性、手指の皮疹を主訴に来院した。自宅で熱帯魚を飼育していた。6ヶ月前、右中指指背に擦過傷を受傷したが、素手で水槽内の熱帯魚に触れていた。1ヶ月後、皮疹が出現したが放置したところ徐々に拡大してきた。手指の写真を次に示す。生検病理標本でZiehl-Neelsen染色陽性の病原体を認めた。診断はどれか



- a. 壊疽
- b. 丹毒
- c. 非結核性抗酸菌症
- d. 梅毒
- e. 癰疽

非結核性抗酸菌症



【Mycobacterium marinum】

プールや熱帯魚の水槽などで感染
軽微な傷から感染して皮膚に腫瘍形成
リンパ流に沿って播種される場合がある

治療はテトラサイクリン、ニューキノロンなど
長期に投与が必要

【Mycobacterium avium】

24時間風呂や温泉で感染
四肢や臀部に腫瘍を形成する

治療はマクロライド、ニューキノロン、抗結核
薬など

ライム病

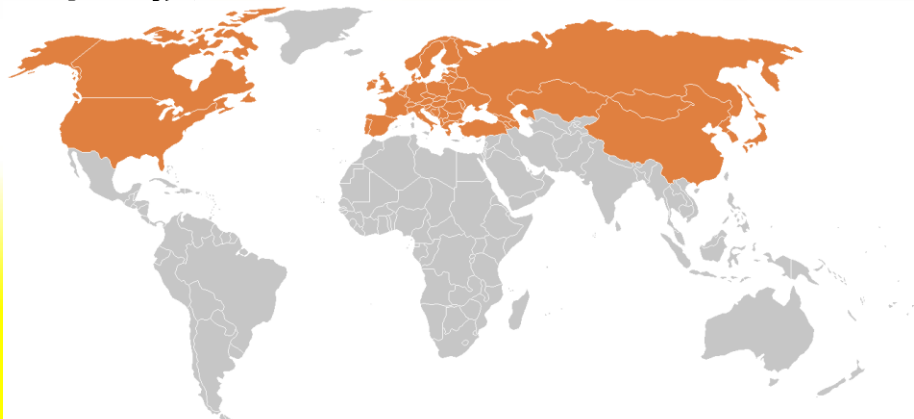
マダニに咬まれてから数日～数週間で
発症

感染初期は咬まれた部位の周囲に紅斑
(遊走性環状紅斑)

その後に筋症状、神経症状、眼症状な
どが出現する。

原因はスピロヘータの一種、ボレリア・ブ
ルグドルフェリ (*B. burgdorferi*)

治療はドキシサイクリン、テトラサイクリ
ン等の投与



重症熱性血小板減少症候群

(Severe fever with thrombocytopenia syndrome: SFTS)

- ・2011年に初めて報告されたブニヤウィルス科フレボウィルス属に分類されるウィルスによるダニ媒介感染症
- ・6日～2週間の潜伏期を経て発熱、消化器症状、神経症状、リンパ節腫脹、出血症状を呈する。
- ・検査では白血球減少、血小板減少、AST/ALT/LDHなどの上昇を認める。
- ・現在、日本での報告は963例(2024年まで)
- ・致死率は約30%と高値である。
- ・治療薬としてファビピラビルが承認された。

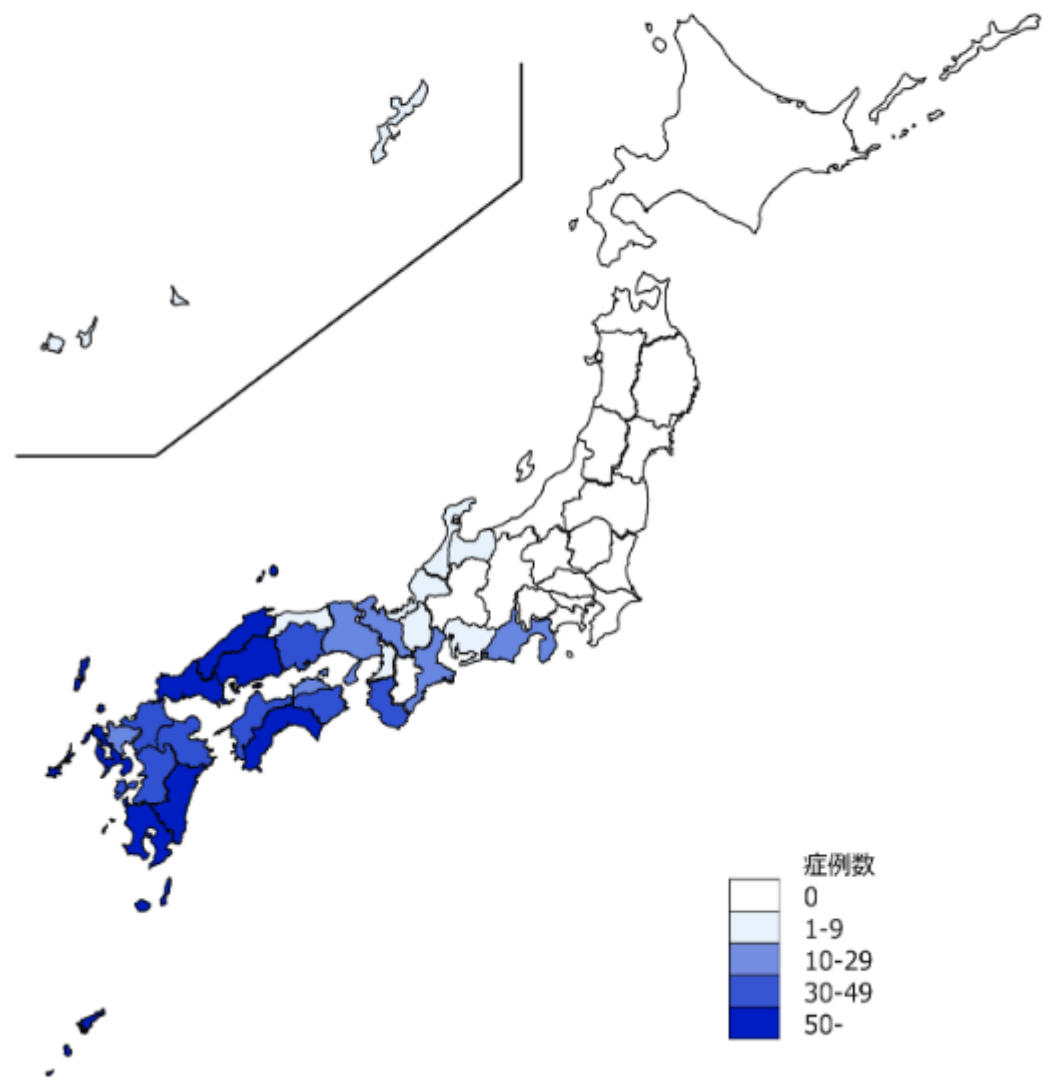


治療薬としてアビガン (ファビピラビル)が承認された



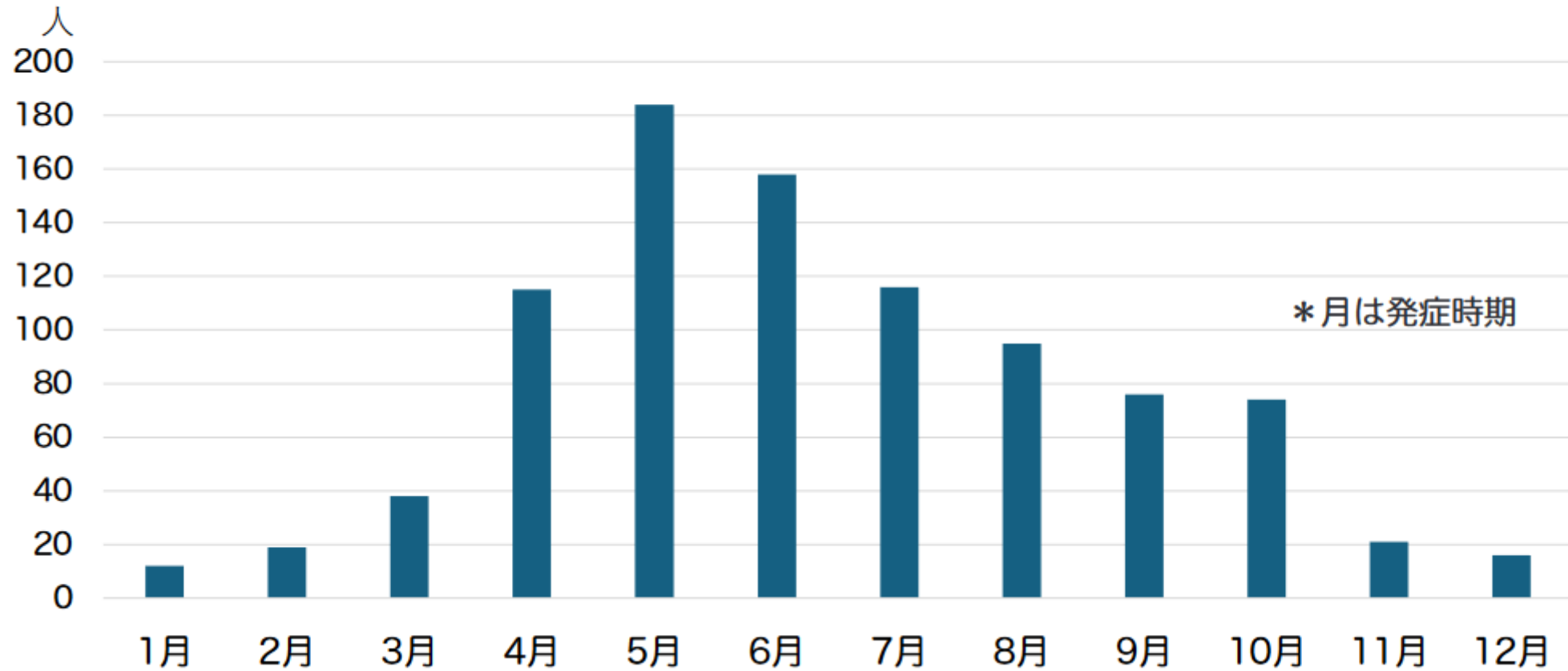
マダニ媒介感染症 SFTS治療薬に「アビガン」 正式承認の見通し

図 4-2 SFTS 症例の推定感染地域 (n = 963, 2024 年 4 月 30 日現在)



推定感染都道府県	症例数
富山県	1
石川県	2
福井県	3
静岡県	13
愛知県	2
三重県	29
滋賀県	3
京都府	12
大阪府	1
兵庫県	11
和歌山県	36
鳥取県	7
島根県	52
岡山県	32
広島県	78
山口県	78
徳島県	39
香川県	24
愛媛県	40
高知県	74
福岡県	31
佐賀県	16
長崎県	77
熊本県	40
大分県	49
宮崎県	110
鹿児島県	79
沖縄県	1
不明	23

図 2-1 SFTS 症例の発症月別届出数 (884 例 : 2014-2023 年)



症例

31歳、女性。

自宅でお好み焼きを作って食べたところ、呼吸困難と全身のじんましんが出現したため救急外来受診。受診時収縮期血圧60であり、アナフィラキシーショックと診断された。今までこのようなエピソードはない。お好み焼きもよく食べていた。

アナフィラキシーショックの原因として最も考えやすいのは何か？

